R ANTÔNIO DE MOURA CAVALCANTE, S/N, Forum Clóvis de Carvalho Padilha, SÃO MIGUEL, ARCOVERDE - PE - CEP: 56509-310 - F:(87) 38218673

Processo nº 0001797-64.2021.8.17.2220

AUTOR: HENRIQUE NAPOLEAO ARCOVERDE FILHO, KARLA CYBELLE DE LIMA ARCOVERDE

REU: REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

HENRIQUE NAPOLEÃO ARCOVERDE FILHO e KARLA CYBELLE DE LIMA ARCOVERDE, qualificados nos autos, ajuizaram *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER* em face de **REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, igualmente identificado no processo, aduzindo: "o Senhor Henrique Napoleão Arcoverde devidamente segurado pelo segundo Requerido, foi internado no hospital ora Requerido por ter sido contaminado pela COVID – 19. Após ter seu estado de saúde agravado, o referido foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do primeiro Requerido, onde passou a ter todos os cuidados médicos e necessários para sua sobrevivência. Desta feita, na necessidade de garantir a vida do paciente, o hospital passou a utilizar o paciente o medicamento actemra, ficando certo que o plano de saúde faria a cobertura deste suporte médico. Infelizmente, mesmo após todo o esforço médico e devido ao agravamento da infecção ocasionada pelo COVID – 19, o paciente veio a óbito no dia 19.05.2021. Passados trinta dias do falecimento do de cujus e para a surpresa de seus filhos, o hospital, ora requerido, passou a cobrar o valor de R$ 7.107,30 (sete mil, cento e sete reais e trinta centavos), pela utilização do medicamento actemra. Ou seja, vê – se que, durante o período em que o de cujus esteve hospitalizado, o plano de saúde tinha o dever de dar toda a assistência possível para manutenção da vida do segurado, dando toda cobertura possível, sem que existisse nenhuma cobrança pelo tratamento". Diante disso, requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança. No mérito, pleitearam a confirmação da medida de urgência, bem como que a condenação do plano de saúde SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A para que realize o pagamento na importância de R$ 16 7.107,30 (sete mil, cento e sete reais e trinta centavos), em favor do REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, em relação ao medicamento actemra utilizado para sobrevivência do Senhor Henrique Napoleão Arcoverde, durante todo o seu tratamento médico hospitalar. Acostaram documentos. Devidamente citados, os demandados apresentaram peça defesa requerendo que a presente ação seja julgada improcedente. Réplica apresentada. Partes intimadas para especificarem as provas pretendidas, ambas requereram o julgamento antecipado do feito. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. **É o relatório. DECIDO.**

DA INÉPCIA DA INICIAL

Diferentemente do que foi apregoado pelo requerido, Real Hospital Português, a peça inaugural não é inepta, vez que se compreende perfeitamente os elementos fáticos e jurídicos evidenciados pela demandante, bem como o teor dos pedidos formulados. Ressalte-se inclusive que a parte ré apresentou contestação de mérito, refutando os argumentos declinados na exordial, o que demonstra claramente que a inicial não é ininteligível. Igualmente, na exordial não está ausente o pedido ou a causa de pedir, há conclusão lógica entre fatos e pedido, bem como não há pedidos incompatíveis.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO

Aduz o demandado que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que a cobrança efetuada é legítima, de modo que os autores não impugnaram a quantia, somente a ausência de cobertura do fármaco pelo plano de saúde. Assiste razão o demandado. Explico.

Dos autos, vislumbro que a controvérsia cinge-se quanto à negativa da seguradora referente ao uso de medicamento utilizado pelo falecido quando internado no nosocômio, de modo que não qualquer irresignação dos autores quanto ao serviço prestado pelo hospital.

Assim, não há que se falar em legitimidade passiva do requerido, pois ausente a sua relação com o caso apresentado aos autos.

Portanto, **acolho a preliminar aventada.**

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que as partes não demonstraram interesse em produzir outras provas além das que já foram trazidas aos autos, motivo que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Por conseguinte, destaco que a relação contratual em comento enquadra-se no conceito de relação de consumo, encontrando-se, em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do serviço, e, de outro, empresas que prestam serviços de saúde, mediante remuneração. Essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei nº 8.078/90, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

Incontroverso nos autos que o genitor dos autores, diagnosticado com COVID-19, fora internado em unidade médica com indicação de uso do medicamento ACTEMRA 20MG/ML FA 4ML (80MG), recusando-se a Sul América a custear tal medicamento, sob alegação de que o fármaco indicado não consta no rol de procedimentos da ANS, é off-label e não consta do contrato (ID 84107662).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da seguradora, entendo que não se justifica a negativa de cobertura no fornecimento de medicamento destinado ao tratamento do de cujus, inicialmente, porque não há exclusão contratual da doença que o acometeu.

A jurisprudência pátria, em situação semelhante, assim já entendeu:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE.* ***Negativa de cobertura do medicamento Actemra 200 mg (Tocilizumabe) para tratamento de COVID-19.*** *Ajuizamento em face do hospital e da operadora do plano de saúde. Sentença de procedência. Irresignação da operadora do plano de saúde. Não acolhimento. Indicação médica para o tratamento.* ***Recusa que se revela abusiva, considerando que o rol de procedimentos e eventos em saúde é meramente exemplificativo.*** *Entendimento expresso no julgamento do REsp.nº 1.733.013/PR, pela C. 4ª Turma do C. STJ, relativo à taxatividade do rol da ANS, que não possui efeito vinculante. Inteligência das Súmulas nsº 95 e 102 desta Corte de Justiça. Medicamento registrado na ANVISA. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao paciente. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível nº 1021663-77.2020.8.26.0554, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/21 – grifei).*
>
> *PLANO DE SAÚDE - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE -* ***Demanda que buscou o custeio de despesas de internação da autora, especificamente com relação ao medicamento Actemra (TOCILIZUMABE),*** *bem como exames Interleucina 6, Pet Scan, PetCTOncológico, Cariótipo com Banda G, sangue periférico e hibridação in situ por fluorescência - Decreto de procedência - Necessidade da autora demonstrada (portadora de mieloma múltiplo e internada para tratamento desta moléstia e de COVID 19),* ***sendo expressamente recomendado o tratamento mediante o uso do fármaco acima referido, pelo profissional que a assiste, assim como os exames - Não cabe ao plano de saúde questionar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico, tampouco exames por ele solicitados (o que afasta a arguição de cerceamento de defesa)*** *- Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça - Agência reguladora que não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o tratamento do paciente - Cobertura devida Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça Precedentes - Valor da condenação que guarda estrita consonância com as despesas a esse título realizadas - Sentença mantida Recurso improvido. (Apelação Cível nº 1080758-42.2020.8.26.0100, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 1/9/21 – grifei).*

*PLANO DE SAÚDE - **Negativa de custeio do medicamento ACTEMRA (Tocilizumabe) para tratamento de COVID-19 - Procedência decretada Abusividade reconhecida - Alegação de que o medicamento não preenche as diretrizes de utilização da ANS, É OFF-LABEL, e não consta do contrato - <u>Inadmissibilidade - Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico</u>** - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos - Relatório médico que justifica a necessidade de utilização do medicamento durante o período de internação do autor - Dever da ré de custear o medicamento indicado ao autor, diretamente junto ao hospital - Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 1003343-59.2020.8.26.0010, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 18/6/21 – grifei)*

Ademais, a operadora de saúde, ao aceitar a cobertura de uma dada doença, não pode restringir o modo como ela será enfrentada pelo profissional de saúde. Cabe ao médico especialista o dever de escolha do melhor e mais adequado tratamento a ser levado a cabo, dentre o leque de opções disponíveis, pois verificará, segundo sua formação, estudos e experiência, qual será o medicamento mais bem indicado para aquele paciente em determinado momento e gravidade da doença.

Outrossim, a alegação de comprovação de ineficácia do medicamento também deve ser afastada.

Acrescento, por oportuno, que a prescrição do medicamento *ACTEMRA (*TOCILIZUMABE) para o tratamento de SARS-COV2 foi objeto da **Nota Técnica nº 37800, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL**, em 13/07/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnicadados (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnicadados). php?output=pdf&token=nt:37800:1642607250:8bfb77d79ad946f28217cf7a10fc2c0318db2fc73323806aa7108a1e89345d71 – acesso em 19/01/2021), que concluiu favoravelmente ao uso do medicamento para o tratamento da moléstia que aflige a população mundial, a saber:

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: O tratamento com tocilizumabe reduziu significativamente as mortes: 596 (29%) dos pacientes no grupo com tocilizumabe morreram em 28 dias em comparação com 694 (33%) pacientes no grupo de cuidados habituais, uma diferença absoluta de 4%. Isso significa que para cada 25 pacientes tratados com tocilizumabe, uma vida adicional seria salva. Tocilizumabe também aumentou a probabilidade de alta com vida em 28 dias de 47% para 54%. Esses benefícios foram observados em todos os subgrupos de pacientes, incluindo aqueles que requerem oxigênio por meio de uma máscara facial simples até aqueles que requerem ventiladores mecânicos em uma unidade de terapia intensiva. Entre os pacientes que não estavam em ventilação mecânica invasiva quando incluídos no estudo, tocilizumabe reduziu de forma estatisticamente significante a chance de progredir para ventilação mecânica invasiva ou morte de 38% para 33%. No entanto, não houve evidência de que o tocilizumab teve qualquer efeito sobre a chance de cessação bem-sucedida da
ventilação mecânica invasiva.x

Por fim, não se olvida que a taxatividade do rol da ANS é questão ainda controvertida nas C. 3ª e 4ª Turmas, havendo inúmeros julgados em sentido contrário no próprio E. STJ, posteriores ao precedente citado (AgInt no REsp. nº 1.899.443/SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 12/4/21; AgInt no AREsp. nº 1.834.599/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30/8/21; AgInt no AREsp. nº 1.754.965/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, j. 30/8/21).

Cito por todos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde

deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifei)

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade do plano de saúde em relação à cobertura do medicamento indicado ao tratamento da autora.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido autoral, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a) DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 7.107,30 (sete mil, cento e sete reais e trinta centavos) em relação à parte autora;

b) CONDENAR a Sul América Companhia de Seguro Saúde a pagar o débito existente junto ao REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO no que concerne ao uso do medicamento, ACTEMRA 20MG/ML FA 4ML (80MG), utilizado pelo extinto, Sr. Henrique Napoleão Arcoverde, no valor de 7.107,30 (sete mil, cento e sete reais e trinta centavos) - ID 84107660 e eventuais acréscimos se houver.

Em relação ao REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO extingo o feito sem resolução do mérito, **com fundamento no art. 485, VI, primeira figura do Código de Processo Civil**, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo da demanda.

Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao ressarcimento do valor pago a título de custas processuais e, ainda, em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais arbitro em 15% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço atento aos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

ARCOVERDE, 9 de setembro de 2022

Cláudio M P Lima

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: CLAUDIO MARCIO PEREIRA DE LIMA
09/09/2022 10:50:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 114354484

22090910501925500000111798097

IMPRIMIR GERAR PDF